2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Liderança tóxica e saúde mental no serviço público de segurança: evidências da literatura científica e reflexões para as instituições de segurança pública

M. C. Begnossi[a*]

[a]*Unidade de Execução Técnico-Científica de Maringá, Polícia Científica do Paraná, Paraná (PR) Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: maria.begnossi@policiaccientifica.pr.gov.br Tel.: +55-44-99923-5615.*

Palavras-chave: Assédio moral; liderança; gestão de pessoas; saúde mental; segurança pública.

1. INTRODUÇÃO

A saúde mental dos profissionais da segurança pública tem recebido crescente atenção da comunidade científica e dos gestores públicos em razão dos impactos do adoecimento psíquico sobre a qualidade de vida dos servidores, a capacidade laboral e a eficiência institucional [1-3]. Policiais, peritos oficiais, policiais penais e demais profissionais da área estão expostos cotidianamente a situações potencialmente traumáticas, elevada responsabilidade funcional, tomada de decisões sob pressão e contato frequente com o sofrimento humano [1,2].

Tradicionalmente, os estudos sobre saúde mental na segurança pública concentraram-se nos efeitos decorrentes da exposição a eventos críticos e situações de violência. Entretanto, pesquisas mais recentes têm demonstrado que fatores organizacionais e psicossociais exercem influência igualmente relevante sobre o bem-estar psicológico dos trabalhadores [3,4].

Nesse contexto, aspectos relacionados à qualidade das relações interpessoais, à percepção de justiça organizacional, ao reconhecimento profissional e às práticas de gestão passaram a ocupar posição central nas discussões sobre saúde ocupacional. Entre esses fatores, destaca-se o papel exercido pelas lideranças, cuja atuação pode funcionar tanto como elemento protetivo quanto como fator de risco para o adoecimento mental dos servidores [4,6].

A literatura internacional descreve que estilos de liderança caracterizados por autoritarismo excessivo, abuso de poder, favorecimento pessoal, humilhações, comunicação hostil e ausência de suporte organizacional podem produzir efeitos significativos sobre a saúde física e mental dos trabalhadores, fenômeno amplamente discutido sob o conceito de liderança tóxica ou destrutiva [5,6].

O presente trabalho tem por objetivo analisar as evidências científicas acerca da relação entre liderança tóxica e saúde mental no serviço público de segurança, discutindo possíveis implicações para as instituições de segurança pública.

2. METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa da literatura científica, realizada por meio de consulta às bases de dados Scopus, Web of Science, PubMed e SciELO, utilizando descritores relacionados à saúde mental ocupacional, liderança tóxica, liderança destrutiva, assédio moral, riscos psicossociais e segurança pública. Foram priorizados artigos científicos, livros de referência e documentos institucionais publicados em periódicos indexados e organismos internacionais.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 Saúde mental e fatores psicossociais na segurança pública

As atividades relacionadas à segurança pública figuram entre as ocupações mais vulneráveis ao desenvolvimento de transtornos mentais relacionados ao trabalho [1,2]. Estudos nacionais e internacionais

apontam prevalência elevada de sintomas de ansiedade, depressão, exaustão emocional, distúrbios do sono, abuso de substâncias e ideação suicida entre profissionais da área [1,2].

Embora os riscos operacionais sejam frequentemente apontados como os principais fatores desencadeadores de sofrimento psíquico, evidências recentes sugerem que os fatores psicossociais presentes no ambiente organizacional exercem influência igualmente importante sobre a saúde mental dos trabalhadores [3,4].

O modelo *Job Demands-Resources* (JD-R), amplamente utilizado na literatura contemporânea, propõe que o adoecimento ocupacional resulta do desequilíbrio entre demandas laborais elevadas e recursos organizacionais insuficientes [3]. Sob essa perspectiva, fatores como excesso de trabalho, conflitos interpessoais, baixa autonomia, ausência de reconhecimento profissional, percepção de injustiça organizacional e deficiência no suporte das lideranças constituem importantes fatores de risco para o desenvolvimento de sofrimento psíquico [3,4].

Diversos estudos realizados com profissionais de segurança pública indicam que problemas internos da organização frequentemente são percebidos como tão ou mais desgastantes que os próprios riscos inerentes à atividade operacional [1,2]. Dessa forma, a construção de ambientes organizacionais saudáveis constitui estratégia fundamental para a preservação da saúde mental e da qualidade dos serviços prestados à sociedade.

3.2 Liderança tóxica e seus impactos organizacionais

O conceito de liderança tóxica refere-se à manifestação persistente de comportamentos destrutivos por parte de indivíduos em posição de autoridade, produzindo prejuízos simultâneos aos trabalhadores e à organização [5,6].

Diferentemente de falhas ocasionais de gestão, a liderança tóxica caracteriza-se pela repetição sistemática de práticas que promovem medo, insegurança psicológica, desconfiança e deterioração das relações de trabalho [5].

Entre os comportamentos mais frequentemente descritos na literatura destacam-se:

- autoritarismo excessivo;
- favorecimento pessoal e parcialidade;
- perseguições profissionais;
- comunicação agressiva ou humilhante;
- desvalorização dos subordinados;
- manipulação de informações;
- ausência de transparência nos processos decisórios;
- utilização do cargo para intimidação ou controle.

Em instituições altamente hierarquizadas, como as organizações de segurança pública, a assimetria de poder entre líderes e subordinados pode dificultar denúncias e favorecer a manutenção dessas práticas ao longo do tempo [5,6].

Além dos impactos individuais, a liderança tóxica compromete a confiança institucional, reduz o comprometimento organizacional, aumenta a rotatividade funcional e prejudica a cooperação entre equipes, afetando diretamente o desempenho organizacional [4-6].

3.2.1. Liderança tóxica, assédio moral e adoecimento psíquico

A literatura científica evidencia forte associação entre liderança tóxica e assédio moral organizacional [5,8]. O assédio pode manifestar-se por meio de críticas constantes, constrangimentos públicos, isolamento profissional, exclusão de processos decisórios, sobrecarga deliberada de trabalho ou retirada injustificada de atribuições.

As consequências dessas práticas para a saúde mental encontram-se amplamente documentadas na literatura. Trabalhadores expostos a ambientes organizacionais abusivos apresentam maior prevalência de ansiedade, depressão, Burnout, sintomas psicossomáticos e afastamentos por motivos de saúde [5,7,8].

Um trabalho realizado com peritos criminais de um estado do nordeste brasileiro, apontou que 25,5% dos peritos avaliados apresentavam a síndrome de Burnout, com maior frequência entre os homens. Quanto ao estresse, a prevalência foi de 34,5%, sendo que a totalidade desses casos se encontrava em fases avançadas de resistência ou quase-exaustão, indicando um desgaste significativo dos recursos adaptativos do organismo. Diferente do Burnout, o estresse foi mais predominante entre as mulheres, atingindo 68,42% das participantes que apresentaram a sintomatologia [9].

Segundo a Organização Mundial da Saúde, ambientes de trabalho psicologicamente inseguros representam fator relevante para o desenvolvimento de transtornos mentais relacionados ao trabalho [10]. A OMS destaca ainda que a promoção da saúde mental exige intervenções não apenas individuais, mas também organizacionais, envolvendo mudanças na cultura institucional e qualificação das lideranças [10].

Enquanto eventos traumáticos operacionais tendem a ocorrer de forma episódica, os problemas organizacionais frequentemente atuam de maneira con-

tínua e cumulativa, favorecendo processos crônicos de desgaste emocional [3,7]. Tal característica contribui para que os efeitos da liderança tóxica sejam potencialmente duradouros e de difícil enfrentamento.

3.2.2. A invisibilidade do sofrimento psíquico entre peritos oficiais criminais

Embora exista crescente produção científica sobre saúde mental de policiais militares e policiais civis, observa-se relativa escassez de estudos direcionados especificamente aos peritos oficiais criminais [1-4]. Essa lacuna limita a compreensão dos fatores psicossociais que afetam essa categoria profissional.

Os peritos oficiais atuam em contextos frequentemente marcados pela exposição a mortes violentas, feminicídios, suicídios, violência sexual, acidentes fatais e outras situações potencialmente traumáticas. Além disso, a atividade pericial exige elevado nível de responsabilidade técnica, produção de provas científicas e tomada de decisões especializadas com relevantes repercussões jurídicas.

Paralelamente aos riscos inerentes à atividade-fim, os peritos também estão sujeitos aos mesmos fatores organizacionais observados em outras carreiras da segurança pública, incluindo conflitos interpessoais, limitações estruturais, escassez de efetivo, pressão por produtividade e problemas relacionados à gestão de pessoas [3,4].

Nesse contexto, lideranças inadequadas podem atuar como fatores amplificadores do sofrimento ocupacional, potencializando os efeitos dos eventos traumáticos já presentes na rotina profissional. A ausência de reconhecimento institucional, a distribuição desigual de demandas e a percepção de injustiça organizacional figuram entre os fatores frequentemente associados à redução do bem-estar psicológico dos trabalhadores [3,4].

Além disso, características culturais historicamente associadas às atividades periciais, como a valorização da objetividade técnica e do autocontrole emocional, podem dificultar a manifestação do sofrimento psíquico e retardar a busca por apoio especializado.

3.2.3. Reflexões para as instituições de segurança pública

As evidências apresentadas sugerem que políticas de modernização institucional devem contemplar não apenas investimentos em infraestrutura e tecnologia, mas também estratégias voltadas à promoção da saúde mental e ao fortalecimento da gestão de pessoas [4,10].

A formação de gestores constitui elemento central nesse processo. Programas de capacitação voltados ao desenvolvimento de competências socioemocionais, comunicação interpessoal, resolução de conflitos, liderança ética e prevenção do assédio moral podem contribuir para a construção de ambientes organizacionais mais saudáveis [4,10,11].

Da mesma forma, a implementação de mecanismos permanentes de avaliação do clima organizacional, escuta qualificada dos servidores e monitoramento dos riscos psicossociais pode favorecer a identificação precoce de situações potencialmente prejudiciais à saúde mental.

O fortalecimento dessas iniciativas tende a beneficiar simultaneamente os trabalhadores, a qualidade dos serviços prestados e a legitimidade das instituições perante a sociedade.

3.2.4 Demandas organizacionais, metas institucionais e sofrimento psíquico na atividade pericial

Além da exposição rotineira a eventos potencialmente traumáticos, os peritos oficiais criminais encontram-se submetidos a um conjunto de demandas organizacionais que podem representar importantes fontes de desgaste psicológico. A literatura sobre saúde ocupacional demonstra que o adoecimento mental não decorre exclusivamente da natureza da atividade exercida, mas também da forma como o trabalho é organizado e gerenciado [3,4].

O modelo *Job Demands-Resources* (JD-R) descreve que o risco de esgotamento profissional aumenta quando as exigências institucionais superam os recursos efetivamente disponibilizados aos trabalhadores para a execução de suas atribuições [3]. Nesse contexto, cobranças excessivas por produtividade, aumento contínuo de demandas, déficit de pessoal, limitações estruturais e insuficiência de suporte organizacional constituem fatores reconhecidamente associados ao desenvolvimento de estresse ocupacional e Burnout [3,7].

No âmbito da atividade pericial, tais questões assumem características particulares. Os exames realizados frequentemente exigem elevado grau de complexidade técnica, observância rigorosa dos protocolos científicos, responsabilidade jurídica significativa e produção de resultados capazes de impactar diretamente investigações criminais e decisões judiciais. Diferentemente de atividades predominantemente quantitativas, a qualidade do trabalho pericial está intrinsecamente relacionada ao tempo necessário para análise técnica adequada, interpretação dos vestígios e elaboração fundamentada dos laudos.

Sob essa perspectiva, a adoção de metas exclusivamente quantitativas, desvinculadas da complexidade dos exames ou da disponibilidade de recursos humanos e materiais, pode gerar conflitos entre produtividade e qualidade técnica. A literatura sobre riscos psicossociais aponta que a percepção de exigências inatingíveis ou destituídas de critérios transparentes constitui importante fator gerador de sofrimento ocupacional, especialmente quando os trabalhadores percebem reduzida autonomia para influenciar as condições de execução do trabalho [3,4].

Estudos sobre justiça organizacional demonstram que a percepção de critérios arbitrários para distribuição de demandas, avaliação de desempenho ou reconhecimento profissional está associada ao aumento de sintomas de ansiedade, exaustão emocional e redução do comprometimento organizacional [4,9]. Em ambientes altamente hierarquizados, tais efeitos podem ser amplificados pela limitada participação dos trabalhadores nos processos decisórios e pela dificuldade de questionamento das decisões administrativas.

Outro aspecto frequentemente discutido na literatura refere-se ao fenômeno da sobrecarga moral do trabalho. Esse conceito descreve situações em que o profissional reconhece a impossibilidade de realizar suas atividades segundo os padrões técnicos e éticos considerados adequados em razão de limitações impostas pela organização. Nesses casos, o sofrimento não decorre apenas do excesso de trabalho, mas da percepção de que a qualidade da atividade desempenhada está sendo comprometida por fatores externos ao controle do trabalhador.

Para os peritos oficiais criminais, essa condição pode assumir relevância particular, considerando que a atividade pericial possui compromisso direto com a produção da prova técnica e com a busca da verdade material. A percepção de impossibilidade de realização adequada das atividades em razão de pressões institucionais, escassez de recursos ou exigências incompatíveis com a realidade operacional pode favorecer sentimentos de frustração, impotência e desgaste emocional prolongado.

Dessa forma, a prevenção do adoecimento mental na atividade pericial exige não apenas intervenções voltadas ao enfrentamento dos eventos traumáticos inerentes à função, mas também a adoção de práticas de gestão capazes de equilibrar demandas institucionais, recursos disponíveis e expectativas de desempenho. A construção de indicadores realistas, transparentes e tecnicamente fundamentados representa medida relevante para a promoção da saúde organizacional e para a preservação da qualidade dos serviços periciais prestados à sociedade.

Os estudos analisados sugerem que fatores relacionados à liderança destrutiva, à injustiça organizacional e à sobrecarga ocupacional atuam de forma integrada na produção do sofrimento psíquico dos trabalhadores. A Figura 1 apresenta uma síntese conceitual dos principais mecanismos identificados na literatura.



Figura 1. Modelo conceitual da relação entre liderança tóxica, fatores organizacionais e sofrimento psíquico em instituições de segurança pública.

3.2.5 Abuso de autoridade organizacional, liderança destrutiva e clima institucional

A literatura científica sobre liderança destrutiva demonstra que os prejuízos decorrentes de uma gestão inadequada ultrapassam os limites das relações interpessoais individuais, alcançando o funcionamento global das organizações [5,6]. Entre os comportamentos mais frequentemente associados a esse fenômeno encontram-se o uso abusivo da autoridade formal, a centralização excessiva das decisões, a utilização de mecanismos de intimidação, a perseguição profissional, a retaliação informal a críticas e a adoção de critérios subjetivos para distribuição de oportunidades e responsabilidades.

Embora nem toda conduta inadequada configure abuso de autoridade em sentido jurídico, diversos autores apontam que o exercício arbitrário do poder hierárquico produz efeitos organizacionais semelhantes aos observados em situações de assédio moral institucional [5,8]. Nesses contextos, os trabalhadores passam a desenvolver estratégias de autoproteção voltadas à redução de conflitos com a chefia, frequentemente em detrimento da criatividade, da cooperação entre equipes e da comunicação transparente.

A literatura também descreve o fenômeno conhecido como silêncio organizacional, caracterizado pela redução da disposição dos trabalhadores em relatar problemas, propor melhorias ou comunicar situações de risco por receio de represálias ou consequências negativas para sua trajetória profissional. Em organizações públicas de segurança, esse fenômeno merece especial atenção em razão das estruturas hierárquicas rígidas e da elevada dependência funcional existente entre subordinados e gestores.

Estudos sobre clima organizacional indicam que ambientes marcados por favoritismos, ausência de critérios transparentes de gestão, baixa previsibilidade das decisões administrativas e percepção de injustiça institucional apresentam maiores índices de sofrimento psíquico, absenteísmo e intenção de desligamento organizacional [4,5]. Além dos impactos sobre os trabalhadores, tais condições podem comprometer a eficiência institucional, a circulação do conhecimento técnico e a qualidade dos serviços prestados.

No contexto das organizações periciais, cuja atividade depende intensamente da autonomia técnica, da cooperação interdisciplinar e da confiança profissional, a qualidade das lideranças assume importância estratégica. A promoção de ambientes organizacionais pautados pela transparência, equidade, participação e respeito aos princípios da administração pública constitui não apenas medida de proteção à saúde dos servidores, mas também elemento fundamental para a manutenção da credibilidade institucional e da excelência técnico-científica da atividade pericial.

4. CONCLUSÕES

A revisão bibliográfica realizada demonstra que a saúde mental dos profissionais da segurança pública é influenciada não apenas pelos riscos inerentes à atividade operacional, mas também por fatores organizacionais relacionados à gestão e às relações de trabalho [1-4].

A liderança tóxica apresenta associação consistente com o aumento de sintomas de ansiedade, depressão, Burnout, estresse ocupacional e insatisfação profissional, configurando importante fator de risco psicossocial no ambiente laboral [5-8].

No contexto das instituições de segurança pública, os impactos dessas práticas podem ser potencializados pelas estruturas hierárquicas e pela elevada dependência funcional das decisões gerenciais.

Ressalta-se que a escassez de estudos especificamente direcionados aos peritos oficiais criminais evidencia a necessidade de novas pesquisas empíricas voltadas à compreensão dos fatores psicossociais que afetam essa categoria profissional.

Conclui-se que a promoção de lideranças saudáveis, associada à implementação de políticas permanentes de gestão de pessoas e promoção da saúde mental, representa estratégia essencial para a proteção dos servidores e para o fortalecimento institucional das organizações de segurança pública.

AGRADECIMENTOS

Agradecimento ao XXVII Congresso Nacional de Criminalística pela oportunidade de participação e apresentação do trabalho exposto, bem como aos colegas peritos criminais, policiais militares, policiais civis e demais servidores da força de segurança pública de diferentes Estados da Federação, que relataram à mim, mesmo que informalmente, a importância e relevância do tema relacionado à gestão e saúde mental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] P.L.M. Oliveira; M.P. Bardagi. Estresse e comprometimento com a carreira em policiais militares. Bol. Psicol. 59: 153-166 (2009).

[2] R.C. Sousa et al. Fatores associados ao adoecimento emocional de policiais militares. Psico-USF 28: 298-312 (2023).

[3] A.B. Bakker; E. Demerouti. Job Demands-Resources Theory: Taking Stock and Looking Forward. J. Occup. Health Psychol. 22: 273-285 (2017).

[4] L.G. Tummers; A.B. Bakker. Leadership and Job Demands-Resources Theory: A Systematic Review. Front. Psychol. 12: 722080 (2021).

[5] M. Einarsen; H. Hoel; D. Zapf; C. Cooper. Bullying and Harassment in the Workplace: Theory, Research and Practice. CRC Press, United Kingdom (2020).

[6] J. Lipman-Blumen. Toxic Leadership: When Grand Illusions Masquerade as Noble Visions. Leader to Leader 36: 29-36 (2005).

[7] C. Maslach; M.P. Leiter. The Truth About Burnout: How Organizations Cause Personal Stress and What to Do About It. Jossey-Bass, United States of America (2016).

[8] S. Einarsen; H. Hoel; D. Zapf; C.L. Cooper (Eds.). Workplace Bullying: Development in Theory, Research, and Practice. CRC Press, United Kingdom (2020).

[9] S.A. Silva; P.M. Souza; F.M. Costa. Sintomas de estresse e Burnout entre peritos criminais. Rev Saúde & Ciên online. 10: 11-25 (2021). Retirado em 02/06/2026, em https://rsc.revistas.ufcg.edu.br/index.php/rsc/article/view/536.

[10] Organização Mundial da Saúde. Mental Health at Work. Retirado em 02/06/2026, de https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-at-work

[11] M. Zanchetta; S. Fellner; E. Traut-Mattausch. Leadership and Employee Mental Health: a Job Demands–Resources Perspective on Health-Promoting and Health-Impairing Leadership. Gruppe. Interaktion. Organisation. (2026).